Клинические рекомендации

Головная боль напряжения

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G44** — Другие синдромы головной боли **G44.2** — Головная боль напряженного типа **G44.3** — Хроническая посттравматическая головная боль **G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках **G44.8** — Другой уточненный синдром головной боли **G90.8** — Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/162_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль 4

3.3 Жалобы и анамнез 5

3.4 Физикальное обследование 5

3.5 Лабораторные исследования 6

3.6 Инструментальные исследования и консультации 6

3.7 Дневник головной боли 6

3.8 Дифференциальная диагностика 6

4. Лечение 7

4.1 Поведенческая терапия 7

4.2 Купирование эпизодов 7

4.3 Профилактическое лечение 8

4.4 Лечение ГБН с лекарственно-индуцированной головной болью 9
4.5 Немедикаментозное лечение 10
4.6 Медицинская реабилитация 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 10
5.1 Профилактика 10
5.2 Показания к госпитализации 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Головная боль напряжения (ГБН) — первичная головная боль: двусторонняя, давящая или стягивающая, слабой или умеренной интенсивности, длительностью **от 30 минут до нескольких суток**; физическая активность её не усиливает, тошноты нет.
- Диагноз клинический — по критериям МКГБ-3; дополнительные исследования при типичной ГБН не нужны. При «сигналах опасности» показаны МРТ головного мозга и консультации, в том числе оториноларинголога.
- Для купирования эпизодов — ибупрофен, кетопрофен, ацетилсалициловая кислота, напроксен; НПВП применяют при эпизодах **не чаще 2 раз в неделю**. При частой эпизодической и хронической ГБН проводится профилактика, препарат первого выбора — #амитриптилин.
- Злоупотребление обезболивающими — ведущий фактор хронизации. Безопасный режим — **не более 2 дней в неделю (8 дней в месяц)**; при лекарственно-индуцированной головной боли препарат злоупотребления ограничивают или отменяют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

ГБН — одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли: двусторонняя боль давящего или стягивающего характера, слабой или умеренной интенсивности, продолжительностью **от 30 минут до нескольких суток**.

Боль не усиливается при обычной физической активности и не сопровождается тошнотой; возможны снижение аппетита, фото- или фонофобия.

2.2 Этиология и эпидемиология

В происхождении ГБН участвуют периферические механизмы (болезненное напряжение мышц головы и шеи, гипоксия мышц, выделение провоспалительных медиаторов) и центральные — снижение активности антиноцицептивной системы ствола мозга с формированием центральной сенситизации. При эпизодической ГБН ведущую роль играют периферические факторы, при хронической — центральные; депрессия и тревога способствуют хронизации.

Распространённость ГБН на протяжении жизни — 78%, за год в России — около 31%. Чаще всего встречается эпизодическая форма (1 день с болью в месяц и менее), не требующая лечения; у 2–3% — хроническая. Средний возраст начала — 25–30 лет.

2.3 Классификация

Формы ГБН (МКГБ-3, 2018)

1. нечастая эпизодическая;
2. частая эпизодическая;
3. хроническая;
4. возможная ГБН — нечастая эпизодическая, частая эпизодическая, хроническая.

Каждая форма подразделяется на сочетающуюся и не сочетающуюся с напряжением перикраниальных мышц. ГБН относится к первичным цефалгиям, не связанным с органическим поражением головного мозга, сосудов и других структур головы и шеи.

2.4 Клиническая картина

Характерные признаки

1. повторяющиеся эпизоды двусторонней диффузной сжимающей непульсирующей боли по типу «каски» или «обруча»;
2. локализация в лобной, височной, теменной, возможно затылочной области или во всей голове;
3. слабая или умеренная интенсивность — 4–7 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ);
4. прогулка и лёгкая нагрузка могут облегчить боль;
5. возможны лёгкая тошнота и снижение аппетита; фото- и фонофобия редки и, в отличие от мигрени, не развиваются одновременно.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагностика клиническая — по соответствию картины критериям МКГБ-3 на приёме невролога.

Диагностические критерии нечастой эпизодической ГБН

1. A. Не менее 10 эпизодов с частотой **не более 1 дня в месяц** (не более 12 дней в году), отвечающих пунктам B–D.
2. B. Продолжительность **от 30 минут до 7 дней**.
3. C. Не менее 2 из 4 характеристик: двусторонняя локализация; давящий, сжимающий, не пульсирующий характер; лёгкая или умеренная интенсивность; боль не усиливается при обычной физической активности.
4. D. Оба признака: отсутствие тошноты или рвоты; только фото- или только фонофобия.
5. E. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Частая эпизодическая ГБН: не менее 10 эпизодов **от 1 до 14 дней в месяц** (более 12 дней в среднем более 3 месяцев и менее 180 дней в году); остальные критерии те же.

Хроническая ГБН: боль **более 15 дней в месяц** в среднем более 3 месяцев (более 180 дней в году), продолжается несколько часов или постоянно; допускаются фото-, фонофобия или лёгкая тошнота, но не умеренная или сильная тошнота и рвота.

При повышенной болезненности перикраниальных мышц при пальпации форма уточняется как «сочетающаяся с напряжением перикраниальных мышц», при её отсутствии — «не сочетающаяся».

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль

ГБН, особенно хроническая, может сочетаться с избыточным применением обезболивающих; лекарственный абузус рассматривается как один из ведущих факторов хронизации.

Обобщённые критерии ЛИГБ (МКГБ-3)

1. A. Головная боль **более 15 дней в месяц** у пациента с исходной первичной головной болью.
2. B. Регулярное злоупотребление **более 3 месяцев** одним или более препаратами для купирования боли.
3. C. Боль не соответствует в большей степени другому диагнозу МКГБ-3.

Формы ЛИГБ по числу дней приёма

Препараты злоупотребления	Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более)
парацетамол, НПВП, ацетилсалициловая кислота, другие анальгетики и антипиретики	**15 и более**

Препараты злоупотребления	Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более)
эрготаминсодержащие препараты, триптаны	**10 и более**
опиоиды, анальгетики с компонентами разных классов, комбинации нескольких классов, другие препараты	**10 и более**

У пациентов с частой эпизодической и хронической ГБН проводится клиническая диагностика ЛИГБ по числу дней с приёмом обезболивающих и типу препаратов (дневник головной боли).

ЛИГБ проявляется диффузной монотонной, чаще утренней или ночной болью, нарастающей с прекращением действия принятого препарата. Наибольший риск — у препаратов с кодеином, барбитуратами и кофеином.

При выявлении ЛИГБ выставляются два диагноза: ГБН и ЛИГБ — для выбора тактики лечения.

3.3 Жалобы и анамнез

Эпизоды боли продолжаются от 30 минут до нескольких дней; при хронической ГБН боль может присутствовать весь день с периодическими усилениями. Эпизоды провоцируются психическим или позным напряжением головы и шеи и облегчаются при психологической релаксации и расслаблении перикраниальных мышц.

У пациентов с ГБН выявляют коморбидные нарушения: они поддерживают мышечное напряжение, способствуют хронизации и требуют коррекции.

Наиболее частые коморбидные нарушения

1. депрессия;
2. тревожные расстройства, в том числе панические атаки;
3. соматоформные и сенесто-ипохондрические расстройства;
4. нарушение ночного сна;
5. другие болевые синдромы, в том числе фибромиалгия.

3.4 Физикальное обследование

Всем пациентам исследуется неврологический статус для исключения органической симптоматики; при типичной ГБН патологии нет.

Возможные находки

1. снижение настроения, тревожность;
2. вегетативные нарушения: гипервентиляция, ладонный гипергидроз, симптом Хвостека I–III степени;
3. неспособность к психологическому и мышечному расслаблению.

Всем пациентам проводится пальпация перикраниальных мышц мелкими вращательными движениями II и III пальцами с обеих сторон.

Области пальпации

1. височные и жевательные мышцы;
2. грудино-ключично-сосцевидные и трапециевидные мышцы;
3. задняя группа мышц шеи (ремённые, нижние косые).

При болезненном напряжении одной или более групп диагноз уточняется: например, «ХГБН с напряжением перикраниальных мышц».

3.5 Лабораторные исследования

При типичной клинической картине без неврологических нарушений лабораторные исследования не рекомендуются. При атипичной картине или «сигналах опасности» выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций и коагулограмма.

3.6 Инструментальные исследования и консультации

При типичной картине и нормальном неврологическом статусе инструментальные исследования и консультации специалистов не рекомендуются. Атипичным считается течение при невыполнении 2 и более критериев МКГБ-3.

При атипичной картине или «сигналах опасности»

1. МРТ головного мозга, МР-ангиография, МР-венография; при невозможности — КТ головного мозга и КТ-ангиография;
2. консультация офтальмолога;
3. консультация оториноларинголога;
4. консультация психотерапевта.

«Сигналы опасности»

1. боль, впервые возникшая после 50 лет, или изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная мигренозная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые неврологические знаки и симптомы системного заболевания: лихорадка, сыпь, ригидность шеи, артралгии, миалгии;
9. признаки внутричерепной гипертензии: усиление боли при кашле, натуживании, напряжении;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. дебют во время беременности или в послеродовом периоде;
13. неэффективность адекватного лечения.

3.7 Дневник головной боли

Дневник **в течение 1–3 месяцев** позволяет установить число дней с болью и с приёмом обезболивающих, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН и выявить лекарственный абузус.

3.8 Дифференциальная диагностика

При нетипичном течении ГБН дифференцируют

1. с мигренью;
2. с головной болью при интракраниальной венозной дисфункции;
3. с головной болью при изменении ликворного давления;
4. с миофасциальной дисфункцией перикраниальных мышц;
5. с цервикогенной головной болью.

Применяются МРТ головного мозга, МР-венография, при необходимости — консультация офтальмолога.

Хроническую ГБН дифференцируют с хронической мигренью и новой ежедневной персистирующей головной болью.

При хронической мигрени, в отличие от ГБН, в начале заболевания были типичные приступы эпизодической мигрени и характерные для неё признаки: наследственный анамнез, типичные триггеры, облегчение во время беременности. Сочетающиеся формы головной боли вносятся в диагноз.

Течение ухудшается при неверных «органических» диагнозах вместо ГБН: дисциркуляторная энцефалопатия, остеохондроз шейного отдела позвоночника, вегетососудистая дистония, гипертензионно-гидроцефальный синдром. Их причина — трактовка неспецифических изменений УЗДГ, МРТ, рентгенографии как органических; итогом становятся психостимуляторы и ноотропы без доказанной эффективности вместо антидепрессантов.

4. Лечение

Ведение пациентов включает поведенческую терапию, купирование болевых эпизодов и профилактическое (курсовое) лечение. Цели — снижение частоты и интенсивности эпизодов и повышение качества жизни.

4.1 Поведенческая терапия

Основные положения

1. разъяснение доброкачественной природы ГБН и разубеждение в органической причине;
2. обоснование нецелесообразности дополнительных исследований, кроме подозрения на симптоматическую боль;
3. роль провокаторов: эмоционального и мышечного напряжения, тревоги, депрессии;
4. необходимость обучения психологическому и мышечному расслаблению;
5. роль факторов хронизации; при злоупотреблении обезболивающими — необходимость отказа от них;
6. цели лечения, механизм действия профилактических препаратов, польза немедикаментозных методов.

4.2 Купирование эпизодов

Препараты для купирования эпизода ГБН

Препарат	Разовая доза	УУР
ибупрофен — препарат выбора	400 мг	A
кетопрофен — препарат выбора	25 мг	A
ацетилсалициловая кислота — препарат выбора	500–1000 мг	A
напроксен — препарат выбора	550 мг (часто 500 мг однократно)	B
#диклофенак — препарат выбора, порошок для раствора внутрь	12,5–25 мг	B
парацетамол	1000 мг	C
анальгетики и антипиретики с кофеином	—	B

Для купирования эпизодов ГБН не рекомендуются

1. **препараты с метамизолом натрия** — высокий риск агранулоцитоза
2. **триптаны, опиоидные анальгетики, миорелаксанты, анальгетики с кодеином или барбитуратами** — высокий риск ЛИГБ

Принципы назначения обезболивающих

1. НПВП эффективнее ацетилсалициловой кислоты, она — эффективнее парацетамола;
2. растворимые формы ибупрофена, кетопрофена, ацетилсалициловой кислоты действуют быстрее;
3. НПВП применяют при эпизодической ГБН с частотой **не более 2 раз в неделю (до 10 дней в месяц)**, чаще — эффект снижается и возникает риск ЛИГБ;
4. учитывают действие НПВП на желудочно-кишечный тракт и риск кровотечений;
5. комбинация ацетилсалициловой кислоты, кофеина и парацетамола эффективнее монотерапии, но при приёме **более 8 дней в месяц** возникает риск ЛИГБ.

4.3 Профилактическое лечение

Профилактическая терапия показана при частой эпизодической и хронической формах для уменьшения числа дней с болью в месяц.

Общие правила

1. разъяснить пациенту, что антидепрессанты обладают и противоболевым действием;
2. дозу повышают медленно для минимизации побочных эффектов;
3. выбранный препарат принимают в переносимой дозе **6–12 месяцев**;
4. при отсутствии эффекта **в течение 3 месяцев** препарат меняют или используют комбинацию;
5. общая длительность — **3–6 месяцев** при эпизодической и **до 12 месяцев** при хронической ГБН.

Препаратом первого выбора является #амитриптилин; большую часть дозы принимают за 1–2 часа до сна.

1. начальная доза: 5–10 мг в сутки
2. титрация: на 5–10 мг **каждую неделю** до эффекта или нежелательных явлений
3. средняя эффективная доза: 50–75 мг в сутки (от 25 до 150 мг)

При противопоказаниях, плохой переносимости или недостаточной эффективности #амитриптилина применяются препараты второго выбора; эффективность других антидепрессантов, в том числе СИОЗС, при ГБН недостаточно доказана.

1. #кломипрамин: 75–150 мг/сут внутрь
2. #венлафаксин: 150 мг/сут
3. #миртазапин: 30 мг/сут
4. #габапентин: 2400 мг/сут — при хронической ГБН и неэффективности или непереносимости антидепрессантов

При выраженной дисфункции перикраниальных мышц в качестве дополнительной терапии применяют миорелаксанты; длительность — **не более 2 месяцев** (в среднем 3–4 недели). Сочетание с антидепрессантом повышает приверженность лечению.

1. #тизанидин: 2 мг 3 раза в сутки, при необходимости до 4–6 мг 3 раза в сутки
2. #толперизон: 450 мг в сутки внутрь

Профилактическое лечение эффективно, если число дней с болью в месяц **через 3 месяца** сокращается **на 50% и более**.

Дополнительные критерии — уменьшение приёма обезболивающих и коморбидных нарушений, повышение работоспособности и качества жизни.

Без улучшения пациента направляют в специализированное болевое отделение или центр лечения головной боли.

4.4 Лечение ГБН с лекарственно-индуцированной головной болью

Лечение включает поведенческую терапию, отмену препаратов злоупотребления, купирование головной боли отмены (детоксикацию) и профилактическое лечение ГБН.

Частая эпизодическая ГБН с 8 и более днями боли и 8–10 днями приёма обезболивающих в месяц — группа риска ЛИГБ. Пациентам разъясняют безопасный режим: **не чаще 2 дней в неделю, не более 8 дней в месяц**.

При лекарственном абузусе препарат злоупотребления существенно ограничивают или отменяют: приём любых обезболивающих — **не более 2 дней в неделю (8 в месяц)**. Отмена анальгетиков проводится амбулаторно, опиоидов и анальгетиков в комбинации с психотропными средствами — в стационаре или дневном стационаре.

В период отмены для лечения «рикошетной» головной боли и других проявлений синдрома отмены проводят детоксикацию **в первые 2 недели**; препараты выбирают по клиническим проявлениям.

1. #преднизолон внутрь: 100 мг 5 дней или 60 мг 2 дня, 40 мг 2 дня, 20 мг 4 дня
1. #метилпреднизолон: 125 мг в 250 мл раствора натрия хлорида внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней вместе с #диазепамом 10 мг и эзомепразолом 40 мг
1. #целекоксиб: 400 мг/сут (200 мг 2 раза) 5 дней, затем снижение на 100 мг каждые 5 дней до отмены

Можно применять обезболивающие тех классов, которыми пациент не злоупотреблял.

1. метоклопрамид при выраженной тошноте и рвоте: 10 мг 1 раз в сутки внутрь или внутримышечно 5–7 дней

Наряду с лечением ЛИГБ проводится профилактическая терапия ГБН — предпочтительно одновременно с отменой препарата злоупотребления; препарат первого выбора — #амитриптилин 50–150 мг в сутки.

При трудностях ведения пациента врачи общей практики, терапевты и неврологи направляют его к специалисту по головной боли или в специализированный центр.

4.5 Немедикаментозное лечение

Для повышения эффективности профилактики, особенно при хронической ГБН, фармакотерапию сочетают с нелекарственными методами.

Нелекарственные методы

1. **биологическая обратная связь по электромиографии мышц скальпа и шеи** — УУР А
2. **когнитивно-поведенческая терапия** — УУР А
3. **постизометрическая релаксация** — УУР А
4. **лечебная физкультура** — УУР В
5. **рефлексотерапия** — УУР В

Серия из 8–15 сеансов биологической обратной связи существенно снижает частоту эпизодов и уровень тревоги.

Как правило, рекомендуется не менее 10 сеансов лечебной физкультуры.

При триггерных точках в напряжённых перикраниальных мышцах и мышцах шеи может применяться их пункция сухой иглой.

Диетотерапия для профилактики ГБН не рекомендуется.

4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитационные мероприятия при ГБН не разработаны.

В дополнение к нелекарственным методам

1. медицинский массаж шеи, воротниковой зоны и спины;
2. релаксационный тренинг, аутогенная тренировка;
3. аэробные физические упражнения, кинезиотерапия;
4. остеопатия, спинальные манипуляции, мануальная терапия.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Пациентам разъясняют роль провоцирующих факторов (прежде всего стресса и позного мышечного напряжения) и факторов хронизации: лекарственного абузуса, хронического стресса, депрессии, тревоги, перенапряжения перикраниальных мышц.

Рекомендуют избегать длительной работы в вынужденной позе, конфликтных и стрессовых ситуаций, избыточного приёма обезболивающих; обучают психологическому и мышечному расслаблению.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в неврологическое отделение

1. головная боль с изменением сознания;
2. головная боль с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. нарастающая очаговая неврологическая симптоматика;
4. нарастающая общемозговая симптоматика;
5. «громоподобная» головная боль.

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. головная боль при избыточном потреблении опиоидов, спазмолитиков, психотропных средств и анальгетиков в комбинации.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. успешная замена препарата злоупотребления на адекватную терапию.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Головная боль напряжения (ГБН)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	162_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Российское общество по изучению головной боли; Союз реабилитологов России
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Граница хронической формы: в критериях (табл. 3g) хроническая ГБН — «более 15 дней в месяц», частая эпизодическая — «от 1 до 14 дней», а в «Терминах и определениях» хронические головные боли — «15 и более дней в месяц»; 15 дней в месяц по критериям не относится ни к одной форме.
- Рекомендация о профилактической терапии ГБН (3.3) содержит вставку из КР по мигрени: «профилактическое лечение пациентам с М, у которых наблюдается 3 и более тяжёлых дезадаптирующих приступа… или ≥ 8 дней с ГБ в месяц, а также пациентам с пролонгированной аурой»; на странице приведено показание для ГБН — частая эпизодическая и хроническая форма.